

RheumaCheck - Fragebogenarchitektur V6

Quellenbasierte Neuordnung des Fragebogenpakets mit vier Modulen

Stand: 11.05.2026 | Arbeitsdokument für IMDB Potsdam / RheumaCheck

1. Ausgangspunkt und wichtigste neue Erkenntnis

Nach erneuter Sichtung des vollständigen RheumaCheck-Projektordners ist die bisherige Dreiteilung grundsätzlich richtig, muss aber präzisiert werden. Die Originalquellen zeigen: Es gibt patientengerichtete Fragebogenanteile, aber die Umfrage zur Standardmethode ist im IMDB-Arbeitspaket AP8 ausdrücklich als Umfrage unter Mitgliedern des Rheumanetzwerks beschrieben. Damit ist ein ärztlich/versorgungsstruktureller Fragebogen kein bloßes Zusatznice-to-have, sondern gehört sehr wahrscheinlich zum Kern der IMDB-Aufgabe.

- **Kernkorrektur:** Bogen 2 sollte nicht mehr primär als Patienten-Ist-Stand-Bogen verstanden werden, sondern als Rheumanetzwerk-/Ärztebefragung zur Standardmethode und zum Versorgungspfad.
- **Weiterhin richtig:** Bogen 1 als Patienten-Anamnese/Stratifizierung und Bogen 3 als Patienten-Usability/Nutzenbogen bleiben fachlich sinnvoll.
- **Neu sinnvoll ergänzt:** Bogen 4 als ärztliche Einschätzung zur Implementierbarkeit und zum erwarteten Nutzen von RheumaCheck; dieser kann später mit Bogen 2 zusammengeführt oder separat geführt werden.

2. Quellenlage im Projektordner

Quelle	Pfad / Dokument	Relevanz für Fragebogenpaket
Gesamtverbundbeschreibung	Antrag/Gesamtvorhabenbeschreibung/ RheumaCheck_Gesamtverbundbeschre ibung_VOLLANTRAG.docx	AP4: Einbindung von Testdaten und Fragebogen; AP7: Patientenbefragung und Stratifizierung; AP8: Vergleich RheumaCheck mit Standardmethode und Auswertung der Ergebnisse.
IMDB-Teilvorhabenbeschreibung	Antrag/IMDB_TVH/Beantragt/ Teilvorhabenbeschreibung-AZA- IMDB_RheumaCheck_VOLLANTRAG.d ocx	AP8: Studie zur Wirkung der Maßnahme auf die Versorgung von RA-Patienten; Erstellung Umfrage zur Standardmethode; Umfrage unter Mitgliedern des Rheumanetzwerks; AP4: Digitalplattform mit Testdaten und Fragebogen.
salvevita-Teilvorhabenbeschreibung	Antrag/salvevita_TVH/salvevita Teilvorhabenbeschreibung- VOLLANTRAG.docx	AP4.1: interaktiver Fragebogen und telemedizinische Plattform; AP4.2: neue interaktive Userelemente; AP5.2: elektronische Formulare, Terminsteuerung und Datenübertragungswege.
IKB-Teilvorhabenbeschreibung	Antrag/IKB_TVH/beantragt/ Teilvorhabenbeschreibung-AZA- IKB_RheumaCheck_VOLLANTRAG.doc x	Rekrutierung von Patientengruppen, Patientendaten für Stratifizierung und Softwareeinlernen, Feedback zur Benutzerfreundlichkeit und Testdesign nach realen Tests.
Zwischenbericht 2025	Berichte/Zwischenbericht 2025/Zwischenbericht_2025_kurz.docx / ZB_13GW0761C_20260210.pdf	Recherche und Vorbereitung der Umfrage zur Standardmethode in Absprache mit IKB.
Jour fixe 09.04.2026	2026_04_09_RC_JF-Protokoll_HPE.pdf	Fragebögen und Begleitforschung: erst Grobabstimmung mit Robert Lange,

		danach Feinabstimmung mit Michael Zänker.
Jour fixe 07.05.2026	2026_05_07_RC_JF-Protokoll_HPE_V2_c.pdf	IMDB hat erste Vorarbeiten zu Fragebögen und Begleitforschung begonnen; Themen bleiben zu schärfen und abzustimmen.

3. Explizit belegte Aufgabenbestandteile

Belegfeld	Originalnahe Aussage	Ableitung für V6
AP4 / Digitalplattform	Einbindung von Testdaten und Fragebogen; Anpassung der salvevita-Software; interaktiver Fragebogen und telemedizinische Plattform.	Patientenbogen A und digitale Infrastruktur; digitale Formularlogik; spätere App-/Plattformfähigkeit.
AP7 / Machbarkeitsstudie	Patientenbefragung und Stratifizierung; Patientengruppen; reale Tests; klassische Labortests parallel.	Patientenbogen A; Patienten-Usability C; klinische Validierung und Testdatenbezug.
AP8 / Erfolgskontrolle	Vergleich RheumaCheck mit Standardmethode; Erstellung Umfrage zur Standardmethode; Umfrage unter Mitgliedern des Rheumanetzwerks.	Ärzte-/Rheumanetzwerk-Bogen B; Wirkungsmessung; Versorgungspfad; Versorgungsnutzen.
salvevita AP5.2	Erforschung und Optimierung elektronischer Formulare, Terminsteuerungselemente und Datenübertragungswege.	Digitale Umsetzung, Sprunglogik, Workflow-Integration, Usability.
IKB-Teilvorhaben	Patientendaten, Rekrutierung, Stratifizierung, Feedback zur Benutzerfreundlichkeit und zum Testdesign.	Klinische Feinabstimmung, Patientengruppen, Datenstruktur, späterer Nutzertest.

4. Bereinigtes V6-Modulkonzept

Das V6-Konzept besteht aus vier getrennten Modulen. Diese Trennung verhindert, dass Patientenanamnese, Versorgungsanalyse, Usability und ärztliche Implementierbarkeit vermischt werden. Zugleich bleibt es möglich, B und D später zu einem gemeinsamen Ärzte-/Rheumanetzwerk-Fragebogen zusammenzuführen, falls die Befragung zu lang wird.

Modul A - Patienten-Vorab-Anamnese und Stratifizierung

Zielgruppe	Patientinnen/Patienten mit unklaren Gelenkbeschwerden oder Verdacht auf frühe RA
Zeitpunkt	vor Test / vor Terminsteuerung / beim digitalen Einstieg
Kerninhalte	Symptombdauer, kleine Hand-/Fußgelenke, Morgensteifigkeit, Schwellung, Schmerz, Funktion, Vorbefunde, Laborwissen, bisherige Abklärung
Quellenlogik	GVB AP4/AP7, IKB-Patientengruppen, NICE/EULAR-RA-Frühzeichen
Umsetzungsform	patientengerichtet; später digital mit Sprunglogik
Status im V6-Konzept	als getrenntes, eigenständiges Fragebogenmodul entwickeln

Modul B - Standardmethode und Versorgungspfad im Rheumanetzwerk

Zielgruppe	Mitglieder des Rheumanetzwerks: Rheumatologie,
------------	--

	Hausärzte/Internisten, Klinik-/Ambulanzakteure, ggf. Praxis-/Studienkoordination
Zeitpunkt	jetzt/früh, als AP8-Erhebung; aktualisierbar vor späterer Auswertung
Kerninhalte	heutiger Standardpfad, Zeit bis Erstdiagnose, Zeit bis Therapieeinleitung, Zuweisungswege, Flaschenhälse, Labor-/Überweisungslogik
Quellenlogik	IMDB AP8: Umfrage zur Standardmethode und Rheumanetzwerk
Umsetzungsform	ärztlich/versorgungsstrukturell; online-Umfrage empfohlen
Status im V6-Konzept	als getrenntes, eigenständiges Fragebogenmodul entwickeln

Modul C - Patienten-Usability, Vertrauen und Versorgungsnutzen nach Nutzung

Zielgruppe	Patientinnen/Patienten bzw. Testnutzer nach App/Test/Workflow
Zeitpunkt	nach Nutzung des Systems bzw. nach Testdurchlauf
Kerninhalte	Verständlichkeit, Blutentnahme/Testhandling, Ergebnisanzeige, Vertrauen, wahrgenommener Nutzen, Zugang zur Rheumatologie, SUS-kompatible Usability
Quellenlogik	IMDB Erfolgskontrolle, salvevita UI, IKB Feedback zur Benutzerfreundlichkeit, SUS
Umsetzungsform	patientengerichtet; ideal direkt in App/Forms
Status im V6-Konzept	als getrenntes, eigenständiges Fragebogenmodul entwickeln

Modul D - Ärztliche Einschätzung, klinische Implementierbarkeit und erwarteter Nutzen

Zielgruppe	Ärztinnen/Ärzte, Rheumatologinnen/Rheumatologen, Hausarztpraxen, Ambulanzen, MVZ, Klinikpartner
Zeitpunkt	bereits jetzt möglich, auch vor finalem Testsystem
Kerninhalte	klinische Sinnhaftigkeit, Einsatzort, Evidenzanforderungen, notwendige Testgüte, Workflow-Integration, Barrieren, Pilotbereitschaft
Quellenlogik	aus AP8/Rheumanetzwerk logisch abzuleiten; stark ergänzendes Begleitforschungsmodul
Umsetzungsform	strategische Ergänzung; kann ggf. mit B kombiniert werden
Status im V6-Konzept	als getrenntes, eigenständiges Fragebogenmodul entwickeln

5. Digitale Zielarchitektur

Die Fragebögen sollten zunächst als Word-/Papier-/Forms-Version fachlich freigegeben werden, aber von Anfang an digitalisierbar gedacht sein. Das bedeutet: klare Antwortoptionen, möglichst wenige Freitexte, definierte Pflichtfelder, eindeutige Variablen, Exportfähigkeit und spätere Sprunglogik.

- **Bogen A:** Sprunglogik bei Gelenkschmerz, Morgensteifigkeit, bekannten Laborwerten und bisherigen Arztkontakten; spätere Verknüpfung mit Testdaten.
- **Bogen B:** Online-Umfrage für Netzwerkmitglieder; Fokus auf Zeitachsen, Prozessschritte, Überweisung und Engpässe.

- **Bogen C:** Ausspielung nach Nutzung des Systems; SUS-kompatible Skala plus projektspezifische Fragen zu Vertrauen, Ergebnisverständnis und Versorgungsnutzen.
- **Bogen D:** Befragung von Ärztinnen/Ärzten zu klinischem Nutzen, Einsatzort, Evidenzanforderungen, Workflow und Barrieren; besonders wertvoll vor finalem Testsystem.

6. Fachliche externe Orientierung

Für die fachliche Schärfung der Fragen sollten die Projektquellen mit aktuellen klinischen und methodischen Standards kombiniert werden. Die folgenden Punkte sind keine neuen Projektverpflichtungen, sondern fachliche Orientierungen für die Ausgestaltung.

Thema	Externe Orientierung	Konsequenz für Fragebögen
Frühe RA-Abklärung	NICE: dringliche Überweisung bei Verdacht auf persistierende Synovitis, besonders kleine Hand-/Fußgelenke, mehr als ein Gelenk, Verzögerung ≥ 3 Monate.	Bogen A muss kleine Gelenke, Mehrgelenkbeteiligung und Symptombdauer systematisch abfragen.
At-risk Arthralgie	EULAR/ACR 2025: Risikostratifizierung berücksichtigt Morgensteifigkeit, patientenberichtete Gelenkschwellung und Schwierigkeit, eine Faust zu machen.	Bogen A sollte Morgensteifigkeit, Schwellung und Faustschluss-/Greiffunktion abfragen.
Telehealth/PROMs	ACR-Telehealth-Anpassung: RAPID3, HAQ-II, MDHAQ und PROMIS PF-10 lassen sich für Telehealth weitgehend adaptieren.	Funktion, Schmerz und Patient Global können kurz und standardisiert erhoben werden.
Usability	SUS: etablierte 10-Item-Skala zur globalen subjektiven Bewertung der Usability.	Bogen C sollte SUS-kompatibel oder SUS-integriert aufgebaut werden.

7. Priorisierter Arbeitsplan für die nächsten Artefakte

1. Bestehenden Bogen A aus V5.1 übernehmen und gegen V6-Quellenlogik prüfen; bei Bedarf klinische Items Morgensteifigkeit, Schwellung, Faustschluss/Greiffunktion, kleine Gelenke schärfen.
2. Bogen B neu aufsetzen: nicht Patienten-Ist-Stand, sondern Rheumanetzwerk-/Ärztebefragung zur Standardmethode, Zeit bis Erstdiagnose und Therapieeinleitung.
3. Bogen C übernehmen und als post-use Patientenbogen mit SUS-kompatibler Usability und projektspezifischem Versorgungsnutzen weiterführen.
4. Bogen D neu erstellen: ärztliche Implementierbarkeit, klinischer Nutzen, notwendige Testgüte, Evidenzanforderungen, Workflow-Integration und Pilotbereitschaft.
5. Gesamtpaket V6 erstellen: vier Einzelfassungen, Gesamtpaket, Entscheidungsfragen für Robert/Michael/Frank, digitale Datenstruktur und kurze Dienstag-/Meetingfassung.

8. Offene Entscheidungsfragen

Adressat	Frage	Warum wichtig
Robert Lange / salvevita	Welche Fragebogenmodule sollen in die Plattform und welche bleiben Forschungs-/Begleitdokumente?	entscheidet über digitale Umsetzung, Pflichtfelder, Sprunglogik, Datenexport
Michael Zänker / IKB	Welche klinischen Items sind für Patientenstratifizierung und Studienlogik unverzichtbar?	entscheidet über medizinische Plausibilität und Patientengruppen
Frank Bier / IMDB	Welche Module sind IMDB-Arbeitspaket,	entscheidet über Projektfokus und

	welche Partnerzulieferung und welche optional strategisch?	Ressourcen
Robert + Michael	Soll Bogen B und D zusammengelegt werden oder getrennt bleiben?	entscheidet über Umfragelänge und Zielgruppenlogik

9. Qualitäts- und Layoutregeln für die nächsten Dokumente

- Jeden Fragebogen als eigenständiges, druckbares DIN-A4-Dokument erstellen.
- Tabellen niemals über Seitenränder hinausziehen; schmale, gut lesbare Tabellen bevorzugen.
- Patientenbögen in einfacher Sprache; Ärztenbögen fachlicher, aber knapp und auswertbar.
- Antwortformate standardisieren: Ja/Nein, Mehrfachauswahl, numerische Skalen, Datums-/Zeitfelder; Freitext nur gezielt.
- Jede Frage erhält idealerweise eine spätere Datenvariable und eine Kategorie: Pflicht / optional / nur Pilotversion.

10. Fazit

Das bereinigte V6-Konzept ist ein vierteiliges, quellenbasiertes Fragebogenpaket. Die wichtigste neue Erkenntnis ist, dass die Standardmethoden-Umfrage aus AP8 explizit an Mitglieder des Rheumanetzwerks gerichtet ist. Damit muss ein ärztlich/versorgungsstrukturelles Modul als Kernbestandteil aufgenommen werden. Die bisherigen drei Bögen waren daher nicht falsch, aber Bogen 2 muss neu gefasst und durch ein zusätzliches ärztliches Implementierungsmodul ergänzt werden.

Anhang: Masterprompt für die nächste Produktionsrunde V6

Erstelle für RheumaCheck ein quellenbasiertes Fragebogenpaket V6 mit vier Modulen. Grundlage sind die Gesamtverbundbeschreibung, die IMDB-, salvevita- und IKB-Teilvorhabenbeschreibungen, der Zwischenbericht 2025 sowie die Jour-fixe-Protokolle vom 09.04.2026 und 07.05.2026. Trenne strikt zwischen belegten Projektanforderungen und fachlich begründeten Ableitungen.

Module:

- A) Patienten-Vorab-Anamnese und Stratifizierung
- B) Rheumanetzwerk-/Ärzte-Umfrage zur Standardmethode und zum Versorgungspfad
- C) Patienten-Usability, Vertrauen und Versorgungsnutzen nach Nutzung
- D) Ärztliche Einschätzung zur klinischen Implementierbarkeit und zum erwarteten Nutzen

Für jedes Modul erstellen:

- Ziel und Projektbezug
- Zielgruppe
- Einsatzzeitpunkt
- empfohlene Länge
- Fragen mit Antwortformat
- Pflichtfelder vs. optionale Felder
- digitale Umsetzungslogik / Sprunglogik

- Auswertungslogik
- offene Abstimmungsfragen für Robert Lange, Michael Zänker und Frank Bier

Fachliche Orientierung:

- RA-Frühzeichen: kleine Gelenke, Mehrgelenkbeteiligung, Symptombdauer, Morgensteifigkeit, Schwellung, Funktion/Greifen/Faustschluss
- Versorgungspfad: Zeit bis Erstdiagnose, Zeit bis Therapieeinleitung, aktuelle Standardmethode, Engpässe und Überweisungspfade
- Usability: SUS-kompatible Erhebung, Ergebnisverständnis, Vertrauen, Nutzungsbereitschaft
- Implementierung: Testgüte, Evidenzanforderungen, Workflow, Rollen, Barrieren, Pilotbereitschaft

Ziel: ein direkt diskutierbares Premium-Arbeitspaket für IMDB Potsdam mit getrennten DOCX/PDF-Einzelfassungen und einem Gesamtpaket.